

Céphalée aiguë inhabituelle (Drapeaux rouges)

- Grossesse et post-partum ⚠ risque de :

- Thrombophlébite cérébrale
- HSA par rupture d'anévrisme
- Tr vasorégulation (éclampsie, PRES)

- Début > 50 ans ⚠ risque de :

- Céphalées symptomatiques
- Horton

- Immunosuppression / HIV ⚠ risque de :

- Infection du SNC (méningite, encéphalite, abcès, parasites)

- Anticoagulants ± traumatisme crânien ⚠ risque de :

- Hématome (intraparenchymateux, sous/extra-dural)

- Cancer, état général :

- Métastases cérébrales

- Céphalée nouvelle/différente

- Céphalée décrite comme la pire

- Céphalée en coup de tonnerre = explosive (<60s)

- Céphalée déclenchée par l'effort, exercice, activité sexuelle

- Céphalée déclenchée/aggravée par Valsalva ou position

- Symptômes neurologiques récents inhabituels

- Symptômes de la maladie de Horton (maux de tête, D+ mâchoire, perte de vision, fièvre, fatigue)

- Anomalie à l'examen neurologique (aura migraineuse p.ex)

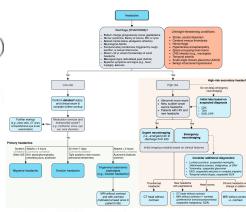
- Rash et/ou méningisme (méningite à méningocoques)

- État fébrile inexpliqué

- Hypertension sévère >180/120

- Mydriase (hypo-/a-réactive) (n.III, ~~compromis~~ ~~sympathique~~ ~~ipsi~~)

- Hornes (myosis, ptosis) (fx sympathique ipsi) ← *Dilatation carotidienne*



Syndrome méningé	Hypertension intracrânienne	Hypotension intracrânienne
Position allongée en chien de fusil	Prédominant en décubitus le matin au réveil	Prédominant en orthostatisme
Nausées, vomissement	Nausées, vomissement en jet le matin au réveil	Nausées après orthostatisme prolongé
Raideur douloureuse de la nuque	Flou visuel et œdème papillaire au fond d'œil	Acouphènes, troubles « fonctionnels » divers
Hémorragie méningée Meningite	Thrombophlébite cérébrale Processus expansif, Autres	Fuite de LCR

- Aura migraineuse ~20% des migraines
 - Précède la céphalée (15-60min)
 - Dure 10-30min (<<60min)
 - Marche migraineuse (dépression corticale envahissante à 3-5 mm/min)
 - Signes essentiellement positifs (diff de l'AVC: signe négatif)
 - Surtout visuelle (parfois somato-sensorielle)
 - Facteur de risque CV

CBH

Migraine épisodique (<15j/mois)

Céphalées durant 4 à 72h (3j) >4h non-ttt

Au moins 2 :

- Localisation unilatérale

- Caractère pulsatile

- Intensité modérée ou sévère

- Aggravation par les activités physiques

Au moins 1 :

- Nausées

- Vomissements

- Photophonophobie

Céphalées de tension

Céphalées durant 30min à 7j

Au moins 2 :

- Localisation bilatérale

- A type de pression ou d'étouffement

- Intensité légère à modérée

- Non aggravation par les AP

Aucun des caractères suivants :

- Nausées

- Vomissements

- Photophonophobie

Névralgies occipitales

- Céphalées cervicogènes

- Névralgies du nerf d'Arnold

- Territoires des nn grands et petits occipitaux

- Type névralgique : en coup de poignard

- Provoquée par les mouvements de la tête

- Nerf sensible à la palpation

- Douleur soulagée temporairement par bloc local

Névralgie trigéminal

- Femme > 50 ans 60-70ans

- Douleur brève (sec) mais répétées (jusqu'à 100x/j)

- Décharge électrique/brûlure dans territoire du trijumeau

- Une ou plusieurs branches

- Zone gachette (toucher, parler, brosser dents, manger)

- Main crispé au visage crispé

IRM pour tous

ttt crise : Valocline i.v.
ttt fond : Carbamazépine (anti-convulsant)

Céphalées chroniques quotidiennes

- ≥15j/mois depuis >3 mois

- 3% population adulte

- Caractéristique sémiologique de migraine et/ou céphalées de tension

- Souvent liées ou aggravées par "abus médicamenteux"

- >15j/mois pour paracétamol, aspirine, AINS

- >10j/mois pour autres antalgiques (triptan, ergotés, opioïdes)

- Comorbidités psychiatriques ++

État de mal migraineux (>72h)

- Migraines hémiplégiques familiales (rares, auto.dominantes)

- Enfants (5%) se plaignent de crise de foie et neurovégétatifs, mal transports. Auras ++

Algie Vasculaire de la Face AVF = Céphalées en grappe = Cluster headache

- Douleur sévère/très sévère

- Unilatérale orbitaire, supra-orbitaire, temporale

- 15-180 min 15min - 3h 1-3x/j

- Associée à au moins 1 des signes suivants coté ipsi :

- Injection conjonctivale ou larmolement

- Sensation de plénitude de l'oreille

- Congestion nasale ou rhinorrhée

- Myosis ou ptosis

- Sudation front et face

- Rougeur front et face

- Œdème paupière

- Agitation

- 8 à 8/j pendant >50% de la période active

jeunes (20-40ans)

IRM

AINS (inefficace et risque de céphalées par abus médicamenteux)

ttt crise : O2 100% Triptans i.v. ou s.c.

ttt fond : Verapamil (prophylaxie)

Examens complémentaires

- Drapeaux rouges :

- IRM/LT

- Selon tableau clinique : PL, FO

- Migraine :

- Pas d'examen

- Céphalées de tension :

- Pas d'examen

- Autres hémicrâniés :

- IRM

- Céphalées provoquées :

- IRM

- Névralgie trigéminal :

- IRM

Traitement migraine

- TT de la crise :

- Le plus tôt possible

- 1ère ligne AINS, 2ème ligne Triptans

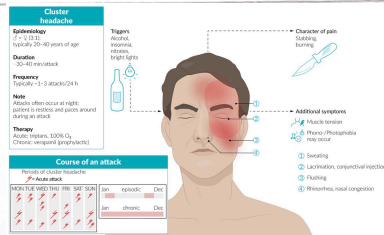
- TT de fond :

- Typiquement si >1 crise/semaine

- B-Bloquant, anytriptuline, topiramate, flunarizine, anti-CGRP

- Magnésium, riboflavine (vit B12)

- Hygiène de vie (sport +++)



Synthèse

Système trigémino-vasculaire: **MIGRAINE**

Nerf trijumeau: **Névralgie trigéminal**

Système trigémino-autonome: **Céphalées en grappe**

-dysautonomique

1) La Migraine

Migraine non traitée = > 4h sinon pas une migraine

- Céphalées durant de **4 à 72 heures** (sans traitement) *4h - 3j → si > 3j = État le mal migraineux ou pas une migraine*
- **Au moins deux** des caractéristiques suivantes :
 1. Localisation **unilatérale**
 2. Caractère **pulsatile**
 3. Intensité modérée ou **sévère**
 4. **Aggravation par les activités** physiques de routine
- **Au moins un** des caractères suivants: **nausées** ou **vomissements** ou **photophonophobie**





Traitement de la migraine

- 1) Rechercher les facteurs déclenchants (très variés) (→ fromages, fruits, OH, ...)
- **Eviter les facteurs déclenchants** (alimentaires, mode de vie, médicaments ...)
 - **Traitement de la crise: LE PLUS TOT POSSIBLE !** → Dès l'aurore!
 - 1^{ère} ligne = ^(AINS) ^(600mg) ibuprofène > paracétamol
Si AINS fonctionnant pas: vasodilat. de vx méninges
 - 2^{ème} ligne = triptans (≤ 2/jours, ≤ 2 jours/semaine) *EI: Fatigue, séq, sensation d'oppression* *CI: atcd d'AVC*
 - **Traitement de fond si invalidant (> 4 jours/mois)** → À prendre ts les j.
 - Magnésium, vitamine B2
 - 1^{ère} intention: propranolol, ^{β-bloquants} métoprolol, ^{anti-calcaïque} flunarizine, ^{anti-épileptique} topiramate, ^{anti-dépresseur} amitriptyline
médic. d'autres souffrances
 - 2nd intention: anticorps monoclonaux anti-CGRP
médic. dev. pour la migraine
 - **Traitements complémentaires jouent un rôle important**
 - acupuncture, médecine manuelle, TENS, auto-hypnose, relaxation/yoga/méditation

2) Céphalées en grappe

Homme (> femme) jeune: 20-30 ans *Homme jeune*

Forme épisodique: double périodicité

- accès ½-2 fois/an, durée de plusieurs semaines (6-12)
- crises quotidiennes (1-2) à heures fixes (1/3 la nuit)
- aux changements de saison (février, Juin)

Forme chronique

- < 1 mois libre de crise

2) Céphalées en grappe: Sémiologie

Hémicranie + signes sympathiques

Douleur **sévère/très sévère** unilatérale orbitaire, supra-orbitaire, temporale **15-180 min**

Associée à **au moins un des signes** suivants, du **coté** de la douleur:

- injection conjonctivale ou larmoiement
- sensation de plénitude de l'oreille
- congestion nasale ou rhinorrhée
- myosis ou ptosis
- sudation du front et de la face
- rougeur du front et de la face
- œdème de la paupière
- **agitation**



De **1/2 jours à 8/jour** pendant au moins la moitié de la période active

2) Céphalées en grappe: **Traitements**

- Eviter les facteurs déclenchants (alcool)
- **Traitement de la crise:**
 - **O₂ haut débit** (12 l/min), **triptan d'action rapide** (injectable, intranasal)
- **Traitement de fond**
 - **vérapamil jusqu'à 960 mg/jour**
 - lithium
 - anticorps monoclonaux anti-CGRP, *corticoïdes, antimigraineux, antinévralgiques*
- **Traitements invasifs**
 - blocs / stimulation occipital, ganglion sphéno palatin (*hypothalamus*)



3) **Névralgie trigéminal**: séméiologie

- **Douleur brève** (sec.), mais répétées (jusqu'à x 100/j)
- **Décharge électrique ou brûlure dans territoire du trijumeau**
- Une ou plusieurs branches (rare V1 isolé)
- **Zone gachette** (toucher, parler, brossage des dents, manger)
- La main se porte au visage qui se crispe (tic douloureux)
- Pas d'hypoesthésie sauf si symptomatique (SEP, Zona, neurinome)
 - Tester la **sensibilité cornéenne** !!!



3) Névralgie trigéminalle

- Terrain:
 - Idiopathique: Plutôt la femme après 50 ans
 - Symptomatique: Plutôt jeune femme si sclérose en plaques
- Examens paracliniques:
 - **IRM** dans tous les cas, avec clichés centrés sur le V
- Traitement:
 - Médicaments: **Antiépileptiques** (*bloqueurs canaux Na⁺, gabapentin, clonazepam*)
 - Chirurgicaux: Radiochirurgie, Ballonnet, Décompression



A retenir

Les hémicrânies et douleurs latéralisées de la face incluent de multiples syndromes:

- Avant tout la **migraine > 4 heures** (sans traitement)
- Autres syndromes **50-100 fois plus rares**, mais se souvenir de:
 - la **céphalée en grappe (15 min – 3 heures)**, douleur atroce, dysautonomie
 - la **névralgie trigéminal (fractions de sec. à x sec.)**, décharge électrique
- Diagnostic d'interrogatoire mais IRM pour syndromes hors migraine
- Très nombreuses erreurs diagnostiques (douleurs dentaires, sinusite)